



表 8 VA-ECMO 临床启动快速筛查评估表(1)

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女
住院号		评估时间	20__年__月__日__时__分
启动场景	☐ 普通 VA ☐ ECPR(心跳骤停) ☐ 术中/术后脱机困难	年龄	__岁
第一步：绝对禁忌筛查(任何一项勾选"是"→ 通常不建议启动 VA-ECMO)			
筛查项目			是否
存在致命性且不可逆原发疾病，或预期寿命极差(如终末期恶性肿瘤、慢性器官衰竭终末期等)			☐☐
心脏功能基本无恢复可能，且无心脏移植或长期 LVAD 指征			☐☐
人工机械主动脉瓣（外周 VA-ECMO 时瓣叶不开放→瓣膜血栓风险极高）			☐☐
严重不可逆神经系统损伤(如脑死亡、全脑缺氧严重脑损伤、广泛脑创伤或大面积脑出血)			☐☐
急性 A 型主动脉夹层（术前）/B 型夹层伴广泛分支受累			☐☐
严重的、无法控制的活动性出血或不可逆的凝血功能障碍			☐☐
有任何"是"→停止评估,VA-ECMO 不适合。ECPR 需 2 分钟内做出判断，无绝对禁忌→立即启动,不延迟。			
第二步：难治性心源性休克指标评估[已给予最佳药物治疗(容量优化+血管活性药+正性肌力药)仍无改善]			
2.1 起效时间判断（不需一律等 6 小时）			
病因	最短观察时间	说明	
暴发性心肌炎/心脏术后脱机困难/药物中毒/大面积 PE	2-3 小时	病情可急剧恶化，不宜久等	
AMI 心源性休克/终末期心肌病急性失代偿	3-6 小时	需确认对药物+IABP 无效	
ECPR（心跳骤停）	不适用此标准	见(表 12-14),CPR≥15 min 未 ROSC 即可启动	
2.2 组织灌注不足指标（满足 ≥3 项）			
指标	异常标准	当前值	
收缩压	SBP<90mmHg，或需大剂量血管活性药维持	SBP___ / 去甲___ μg/kg/min	
心脏指数（如有 PAC）	CI <2.0 L/min/m ²	___ L/min/m ²	
超声 LVEF	LVEF < 20-25%或 LVOT VTI < 10 cm	LVEF___% / VTI___ cm	
血管活性药剂量	去甲>0.3μg/kg/min+多巴酚丁胺>10 μg/kg/min,仍无效	去甲___ 多巴酚丁胺___	
尿量	< 30mL/h（或<0.5 mL/kg/h）	___ mL/h	
乳酸	> 2.0mmol/L 且持续不降或上升	___ mmol/L	
ScvO ₂ / SvO ₂	<60%	___ %	
意识状态	改变（精神萎靡/谵妄/昏迷）	☐ 有 ☐ 无	
第三步：病因/适应症勾选(核心适应症)			
病因	病因		
急性心肌梗死导致的心源性休克	心脏直视术后（含心脏移植/LVAD 术后）急性心源性休克/脱机困难		
暴发性心肌炎	重度药物/毒物中毒导致的心脏毒性或心功能抑制		
大面积肺栓塞伴循环不稳定			
第三步：病因/适应症勾选(扩展与新型适应症)			
病因	病因		
ECPR:难治性心脏骤停,常规 CPR≥15-20min 未 ROSC	高危 PCI/CABG 术中后备支持		
重度恶性心律失常（电风暴）致难治性循环不稳定	脓毒症相关心肌病		
严重低体（<30℃）伴循环不稳定	产后急性心肌病		

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIOJ)+SAVE 评分(Schmidt et al.2015)+ECPR 相关指南(AHA 2025)

用途：VA-ECMO 启动前的快速四步评估，5-10 分钟内完成

配套使用：表 15（SAVE 评分）+ 表 12-14（ECPR 专项流程）